

Pneumonia comunitária · pediátrica

PAC na criança é diagnóstico clínico-radiológico. Idade orienta etiologia e antibiótico; taquipneia, tiragem e SatO₂, baixa definem gravidade e internação.

Etiologia por idade (visão clássica)

Lembre - Etiologia por idade (visão clássica)

Neonato: GBS, enterobactérias, Listeria. Lactente/pré-escolar: vírus + pneumococo. Escolar/adolescente: pneumococo e atípicos (Mycoplasma).

Triagem: SatO₂, esforço respiratório e capacidade de se alimentar decidem o nível de cuidado.

PAC pediátrica - gravidade

Ambulatorial / enfermaria / UTI

Ambulatorial

Bom estado geral
SatO₂ adequada
Aceita VO / ATB VO

Retorno precoce

Enfermaria

Tiragem / taquipneia
SatO₂ baixa
ATB EV +/- O₂

Monitorar

UTI

Distress grave
Apneia / cianose
Choque / falha ventilatória

Suporte avançado

Antibiótico empírico (ideia R1)

- Amoxicilina VO é 1ª linha na PAC bacteriana não complicada em ambulatorial
- Penicilina/ampicilina EV em internados sem complicação (conforme protocolo)
- Associar cobertura atípica quando clínica compatível no escolar
- Neonato e toxemia: esquema amplo + investigar sepse

Internação — critérios frequentes

Critério | Exemplo

Hipoxemia | SatO₂ < 92% em ar ambiente

Esforço | Tiragem subcostal, gemido, batimento de asa

Ingestão | Recusa / desidratação

Social / falha | Vômitos de ATB, dúvida de adesão

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Sibilância isolada em lactente sugere mais bronquiolite/viral do que 'pneumonia bacteriana típica'. Não automatize ATB sem critérios de gravidade/focalidade.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Crítérios de internamento separam pneumonia comunitária tratável em casa de casos que precisam de O₂, hidratação EV e vigilância.

SatO₂ ,, esforço respiratório, idade e capacidade de ingerir líquidos decidem a via de cuidado.

Critérios de internamento

Pneumonia pediátrica

- 1 SatO₂ baixa em ar ambiente
- 2 Tiragem importante / FR muito alta
- 3 Apneia ou cianose
- 4 Desidratação / vômitos incoercíveis
- 5 Lactente jovem / imunocomprometido
- 6 Complicação (derrame, sepse)

Toxemia / apneia = internar

Leve em casa com ATB oral; moderada/grave com O₂ e ATB EV.

Gravidade clínica

Ambulatório / enfermaria / grave

Leve

Bom estado
SatO₂ ok
Aceita VO

Casa + ATB VO

Moderada

Tiragem
SatO₂ limiar
Ingesta baixa

Internar

Grave

Distress
Choque / sepse
Falência respiratória

UTI / suporte

Etiologia por idade (visão clássica)

Idade | Agentes frequentes

Neonato | GBS, gram-negativos, Listeria

1–3 meses | Vírus, Chlamydia, bactérias típicas

Pré-escolar | Vírus, pneumococo

Escolar/adolescente | Pneumococo, Mycoplasma

Conduta

- Amoxicilina VO é clássica na pneumonia típica ambulatorial
- O₂ se hipoxemia; hidratação e antitérmico de suporte
- RX não atrasa ATB se clínica clara e gravidade
- Pensar derrame/empiema se febre persistente ou assimetria

Armadilha

Atencao - Armadilha

Sibilância isolada em lactente no inverno pode ser bronquiolite — não rotule tudo como pneumonia bacteriana.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1